2.3.6.2. 영상검사 결과 보고 – 핵의학과

제 정 일	2006.05.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	핵의학과				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.3.6 영상검사 결과 보고 절차 JCI Standard 7th Edition: AOP.5.1, 5.4, 5.5, 5.9.1, 6.1, 6.3~6.6, IPSG.2, 2.1

제1조 (목적)

1. 환자의 생명을 위협하거나 위해를 줄 수 있는 핵의학과 영상검사 결과 보고체계 및 관련 의사소통 절차를 확립하여 적절한 진료 및 환자의 안전을 도모하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. PACS(Picture Archiving Communication System): 의료 영상을 디지털 형태로 저장, 전송, 진단하는 시스템
2. EMR: Electronic Medical Record

제3조 (절차)

1. 핵의학과 영상검사 결과보고
   1) 검사종류별 보고방법
      (1) 검사 보고방법: 촬영한 영상에 대해 처방, 환자정보 및 검사 목적에 적합한지 확인하고 PACS 시스템으로 영상을 전송하여 판독이 되도록 지원한다. 판독이 완료되면 판독결과를 EMR로 전달하여 관련 의료진이 조회할 수 있도록 한다.
      (2) 검사부서는 각각의 검사결과의 판독 및 보고에 대한 기준 범위(참고치)를 확립하며 세부지침은 부서별 업무규정에 따른다.
   2) 검사결과 보고시간(Turn-Around Time, TAT)
      (1) 검사결과 보고시간이란 검사 완료시부터 판독 완료시까지의 시간을 말한다.
      (2) 정규검사
         ① 입원: 입원 환자 검사 시 TAT는 48시간 이내로 하되 단, 금오일 시행한 환자는 96시간 이내로 한다.
         ② 외래: 외래에서 처방되어 시행하는 핵의학 영상검사 TAT는 7일 이내로 한다. 외래 진료예약이 7일 이전에 예약된 환자는 외래 진료예약 이전 시간까지로 한다.
      (3) 응급검사: 환자가 수술을 요하거나 임상과에서 긴급검사 요구 시 TAT는 24시간 이내로 시행한다.

2. 이상 검사결과 보고(Critical Value Report, CVR)
   1) 보고 대상 및 기준: 핵의학과 검사 유형에 따라 이상검사결과 보고 기준을 확립하며, 세부지침은 [부록 2. 핵의학과 CVR 지침]을 참고한다.

2) 이상검사결과 확인 시 보고 절차

(1) 검사결과에서 Critical Value가 확인되면 핵의학과 판독의사 또는 전문의가 담당 의료진에게 판독 결과를 문자 전송 또는 유선으로 알린다.

(2) 검사부서에서는 이상검사결과 리스트 및 보고 현황을 관리한다.

3. 보고된 검사결과가 변경될 경우 보고절차

1) 동일검사 결과보고의 결론이 변경된 경우에는 의료진에게 문자 또는 유선으로 알린다.

2) 유선으로 검사결과 보고 시, 세브란스병원 내규 [1.2.1. 구두/전화처방]에 따른다.

4. 검사의 판독과 결과 보고에 필요한 경우 임상적 이유가 처방 또는 판독의뢰서에 포함된다.

5. 결과보고소요시간(TAT)은 병원에서 정한 지침에 따르며, 세부적인 지침은 부서별 및 검사항목별로 정한다. TAT 결과를 모니터링하고 분기별로 보고하며, 이를 의료진간 공유한다.

제4조 (부록)

1. 핵의학과 TAT 지침
2. 핵의학과 CVR 지침

제5조 (참고)

1. 환자안전 주의경보 '이상검사결과의 보고(CVR) 지연 또는 누락'(의료기관평가인증원 중앙환자안전센터, 2020.10.)

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2006년 5월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)